



Index: 011

Arquivo: Sonoendoscopia do Sono (DISE) 26-09-2019.pdf
Original: Cliente PAULO AUGUSTO SILOTTTO DIAS DE SOUZA.pdf

CLASSIFICACAO · inferencia IA

Categoria: Colonoscopy/Endoscopy

CONF: ALTA

Subtipo: Endoscopia do sono induzido (sonoendoscopia / DISE sob sedação com propofol) para avaliação de apneia obstrutiva do sono; classificação VOTE (Velo 2CC, Orofaringe 2LL, Língua 2AP, Epiglote 0)

PROVENIENCIA · os cinco campos (dados do documento)

Data do exame	26-09-2019
Data de ingestao	pendente (definida na ingestao)
Medico solicitante	Dr. Fabio Augusto Winckler Rabelo
Medico executante	Dr. Fábio Rabelo
Laboratorio	não informado
Cidade / Pais	não informado / não informado

RECOMENDACAO DE INGESTAO · inferencia IA (nao verificada - repo ausente)

Tabela(s): documents, imaging_studies

Campos: procedure_type, vote_classification, exam_date, ingested_at, requesting_doctor, performing_doctor, lab, city, country

Chave R2: patients/{id}/procedures/2019-09-26-sonoendoscopia-do-sono.pdf

PROMPT

[LACUNA] propor: Sleep Endoscopy (DISE) Ingestion.txt

FRONTEND · render_class: unknown

Secao: physical-exams Acao: needs a render surface decision (bespoke vs database-default) before display

FLAGS: **provenance-incompleta** new-category-DISE mapping-unverified

Cliente: PAULO AUGUSTO SILOTTO DIAS DE SOUZA
Data de nascimento: 14/07/1961 (58 anos)
Solicitante: Dr(a). FABIO AUGUSTO WINCKLER RABELO
Exame: ENDOSCOPIA DO SONO (SONOENDOSCOPIA)

Data do exame: 26/09/2019
Nº Atendimento: 6147493

ENDOSCOPIA DO SONO INDUZIDO (NASOFIBROLARINGOSCOPIA SOB SEDAÇÃO)

Realizado exame com endoscópio flexível, por via nasal, para avaliação dinâmica da via aérea superior em situação de sono induzido com propofol (bomba de infusão alvo controlada), sem utilização de anestésico tópico.

Os parâmetros da sedação durante o exame foram: concentração efetiva estimada de propofol de 3,5 mcg/ml e BIS mantido com valor entre 55-70.

Os achados seguem descritos abaixo:

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO EXAME:

Observado respiração predominate nasal, com vedamento lingual em palato.
Região nasal com desvio caudal a esquerda, cornetos inferiores hipertroficados, cavum livre.
Durante o exame, apresentou diminuição do calibre de via aérea predominante em regiões: velopalatal concentrica 100%, faríngea laterolateral 100% (com extensão até terço inferior de faringe), retrolingual 100% anteroposterior (base de língua com hipertrofia moderada)

Manobras

- realizado mudança de decúbito para lateral esquerdo sem melhora do padrão obstrutivo
- realizado avanço mandibular com melhora da obstrução em hipofaringe e parcial em região velopalatal (avanço de 5mm – próximo ao máximo tolerado)

Classificação VOTE (Kezirian EJ. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2011 Drug-induced sleep endoscopy: the VOTE classification)

V (velopharynx) – 2CC
O (oropharynx) – 2LL
T (Tongue) – 2AP
E (Epiglottis) - 0

Dr. Fábio Rabelo
CRM 108541
Otorrinolaringologista

